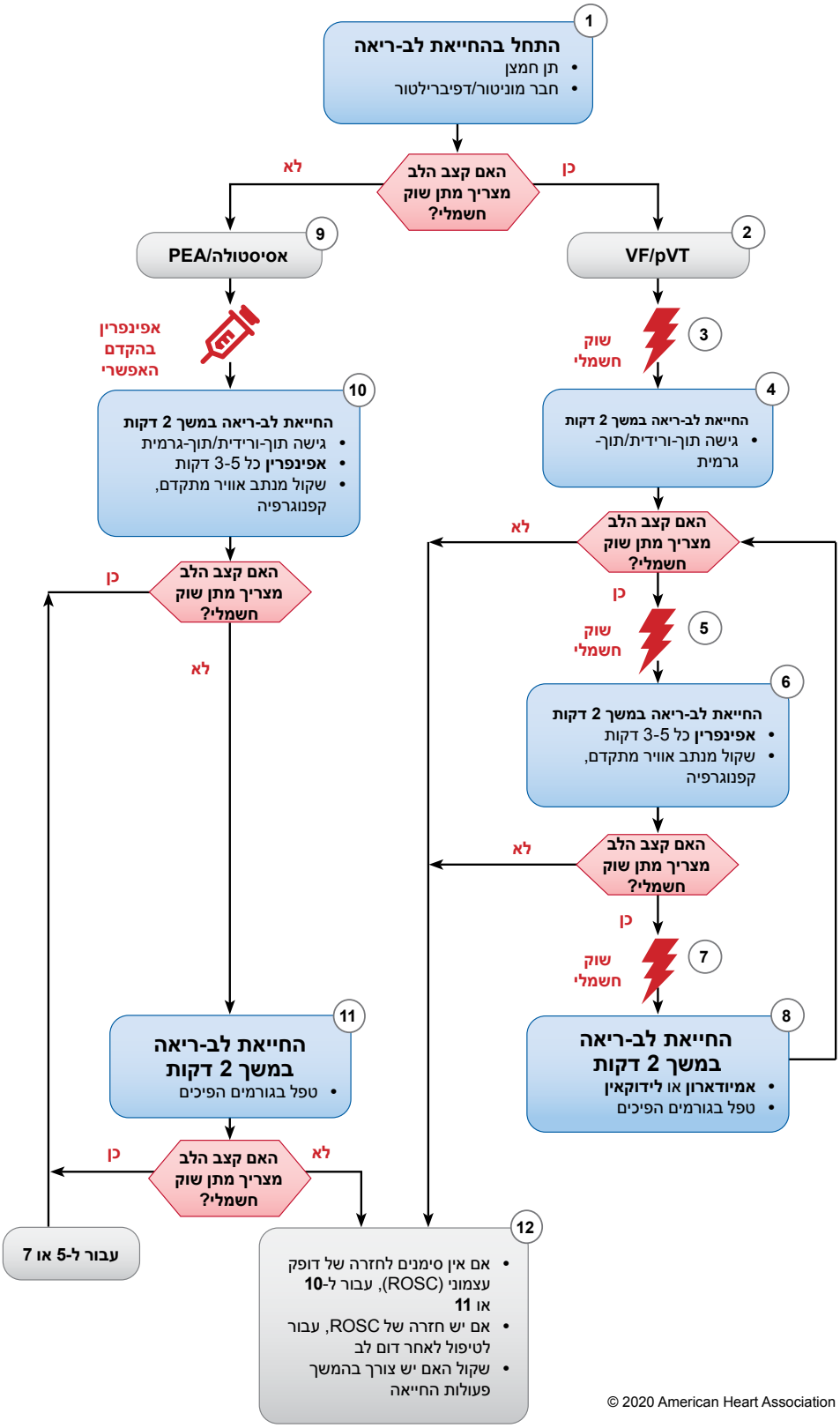
איור 4. אלגוריתם הטיפול בדום לב במבוגרים.



© 2020 American Heart Association

איכות החייאת לב-ריאה

- לחץ לחיצות חזקות (לפחות 2 אינץ' [5 ס"מ]) ומהירות (100-120 לדקה), ואפשר חזרה מוחלטת של בית החזה.
- צמצם למינימום את ההפסקות בעיסוי חזה.
- הימנע מאוורור יתר.
- החלף את המעטה כל 2 דקות, או מוקדם יותר אם התעייף.
- אם אין מנתב אוויר מתקדם, יחס עיסוי-הנשמה 30:2.
- קפנוגרפיה כמותית בצורת גל
  - אם $PETCO_2$ נמוך או יורד, בצע הערכה מחודשת של איכות ה- CPR.

עוצמת שוק חשמלי לדפיברילציה

- **בי-פאזי:** המלצת היצרן (לדוגמה, שוק חשמלי התחלתי בעוצמה של 120-200 ג'אול); אם לא ידוע, השתמש בעוצמה הגבוהה ביותר שזמינה. השוק החשמלי השני והשוקים החשמליים הבאים צריכים להיות שווי ערך לשוק החשמלי הראשון, ואפשר לשקול מתן שוקים חשמליים בעוצמות גדולות יותר.
- **מונופאזי:** 360 ג'אול

טיפול תרופתי

- **מנת אפינפרין במתן תוך-ורידי/תוך-גרמי:** 1 מ"ג כל 3-5 דקות
- **מנת אמיודארון במתן תוך-ורידי/תוך-גרמי:** מנה ראשונה: 300 מ"ג בולוס. מנה שנייה: 150 מ"ג

או

מנת לידוקאין במתן תוך-ורידי/תוך-גרמי: מנה ראשונה: 1-1.5 מ"ג/ק"ג. מנה שנייה: 0.5-0.75 מ"ג/ק"ג.

מנתב אוויר מתקדם

- צנרור תוך-קני או מנתב אוויר מתקדם מעל לפתח הקנה
- קפנוגרפיה בצורת גל או קפנומטריה לאישור ולניטור מיקום הצנרור התוך-קני
- לאחר הימצאות מנתב האוויר המתקדם במקומו, הנשם הנשמה אחת כל שש שניות (עשר הנשמות לדקה) בשילוב עיסוי חזה רציפים

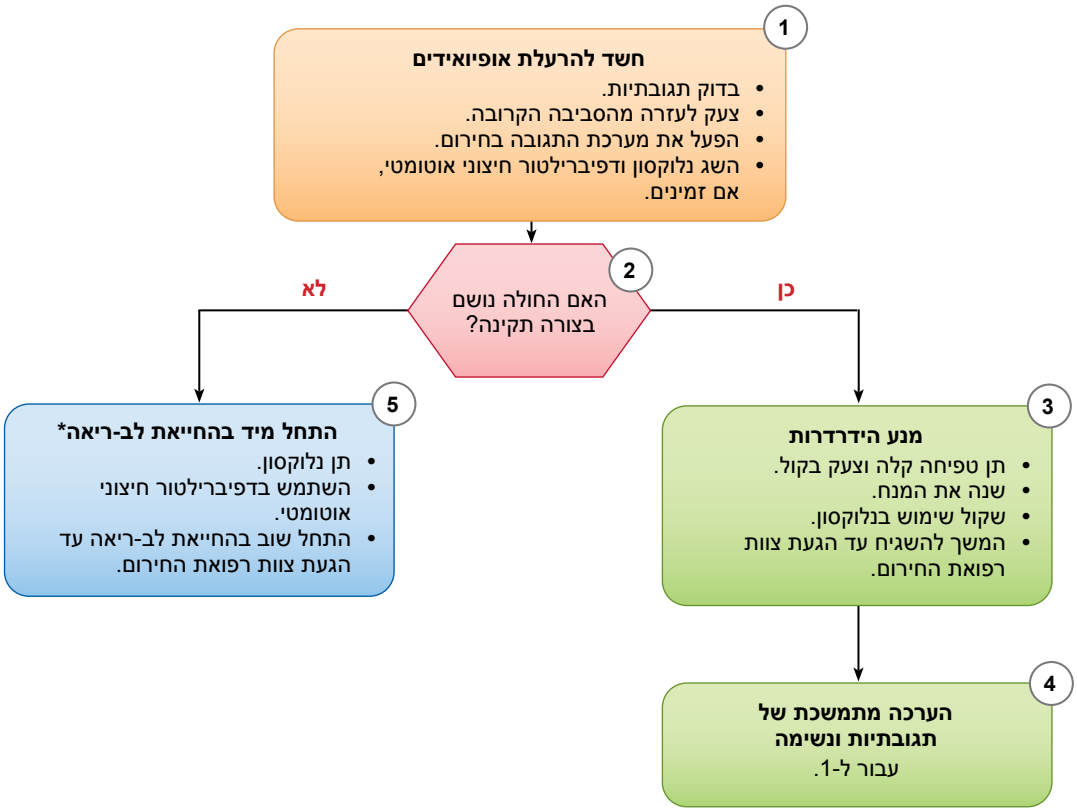
חזרה של דופק עצמוני (ROSC)

- דופק ולחץ דם
- עלייה פתאומית ממושכת ב-$PETCO_2$ (בדרך-כלל ≥40 מ"מ כספית)
- גלי לחץ עורקי עצמוני בניטור תוך-עורקי

גורמים הפיכים

- תת-נפח דם (היפווולמיה)
- חוסר חמצן (היפוקסיה)
- יון מימן (חמצת - אצידוזיס)
- יתר/מיעוט אשלגן בדם (היפו/היפרקלמיה)
- תת חום (היפותרמיה)
- חזה אוויר בלחץ
- טמפונדה לבבית
- טוקסינים
- פקקת, ריאתית
- פקקת, כלילית

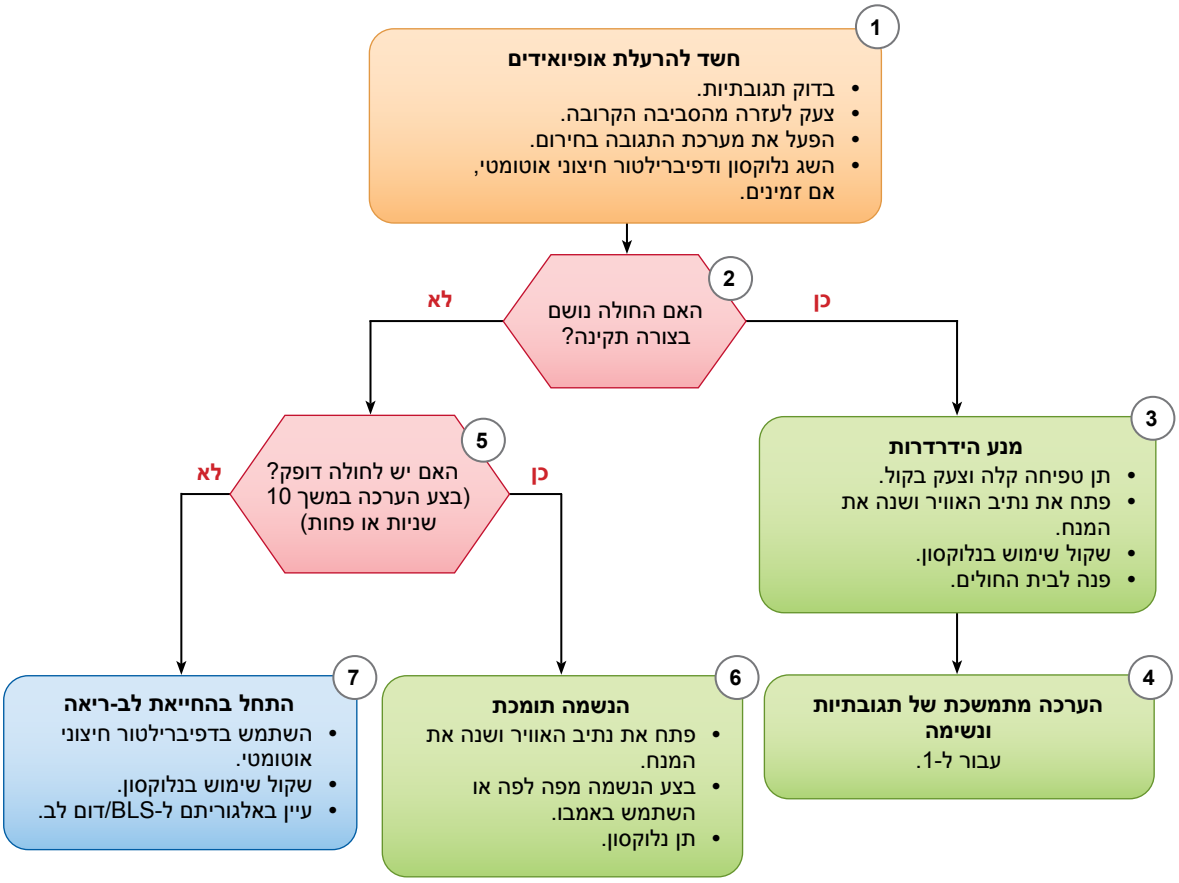
איור 5. אלגוריתם הטיפול במקרי חירום הקשורים לאופיואידים עבור עוברי אורח.



*עבור חולים מבוגרים ומתבגרים, המטפלים צריכים לבצע עיסוי חזה והנשמות מפה לפה במקרי חירום הקשורים לאופיואידים אם הם מאומנים בביצוע פעולות אלה, ולבצע החייאת לב-ריאה באמצעות עיסוי חזה בלבד אם הם אינם מאומנים לבצע הנשמה מפה לפה. בתינוקות וילדים החייאת לב-ריאה צריכה לכלול עיסוי חזה עם הנשמה מפה לפה.

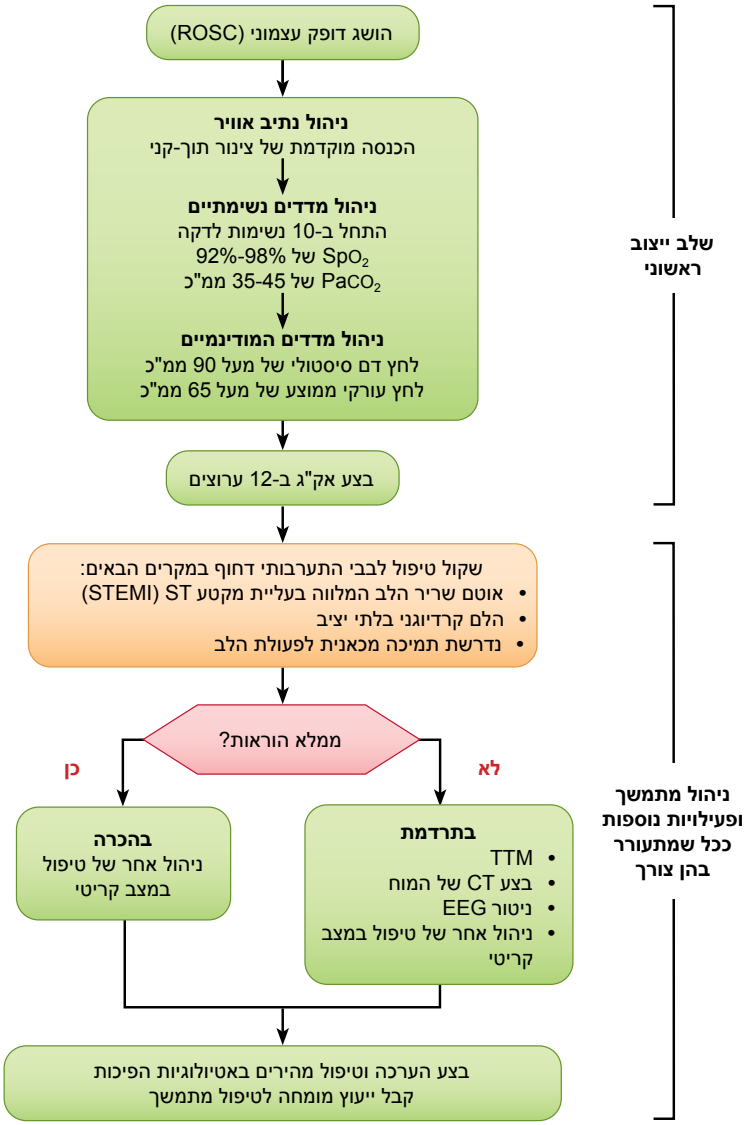
© 2020 American Heart Association

איור 6. אלגוריתם הטיפול במקרי חירום הקשורים לאופיואידים עבור אנשי צוות רפואי.



© 2020 American Heart Association

איור 7. אלגוריתם לטיפול לאחר דום לב במבוגרים.



שלב ייצוב ראשוני

החייאה נמשכת בשלב שלאחר ה-ROSC, ורבות מהפעילויות הללו יכולות להתרחש במקביל. עם זאת, אם יש צורך בתעדוף, בצע את הצעדים הבאים:

- ניהול נתיב אוויר: קפנוגרפיה בצורת גל או קפנומטריה לאישור ולניטור מיקום הצינור התוך-קני
- ניהול מדדים נשימתיים: בצע טיטור של FIO_2 עבור SpO_2 92%-98%; התחל ב-10 נשימות לדקה; בצע טיטור ל-$PaCO_2$ של 35-45 ממ"כ
- ניהול מדדים המודינמיים: תן קריסטלואיד ו/או וואזופרסור או אינוטרופ עבור יעד לחץ דם סיסטולי של מעל 90 ממ"כ או לחץ עורקי ממוצע של מעל 65 ממ"כ

ניהול מתמשך ופעילויות נוספות ככל שמתעורר בהן צורך

הערכות אלו צריכות להתבצע במקביל, כך שההחלטות על שמירה על טמפרטורת יעד מבוקרת (TTM) יקבלו עדיפות גבוהה כהתערבויות לבביות.

- התערבות לבבית ככל שהיא נדרשת: הערכה מוקדמת באמצעות אלקטרוקרדיוגרם ב-12 ערוצים (אק"ג); שקול המודינמיקה להחלטה על התערבות לבבית
- TTM: אם המטופל אינו מבצע הוראות, החל TTM בהקדם האפשרי; התחל ב-32-36°C למשך 24 שעות באמצעות מכשיר קירור עם לולאת משוב
- ניהול אחר של טיפול במצב קריטי
  - ניטור מתמשך של טמפרטורת ליבה (בוושט, רקטלית, בשלפוחית השתן)
  - שמור על נורמוקסיה, נורמוקפניה, אאוגליקמיה
  - בצע ניטור מתמשך או לסירוגין של אלקטרואנצפלוגרם (EEG)
  - בצע הנשמה להגנה על הריאות

גורמים הפיכים

תת-נפח דם (היפוולמיה)
חוסר חמצן (היפוקסיה)
יון מימן (חמצת - אצידוזיס)
היפוקלמיה / היפרקלמיה
חזה אוויר בלחץ
טמפונדה לבבית
טוקסינים
פקקת, ריאתית
תת-חום (היפותרמיה)
פקקת, לבבית

© 2020 American Heart Association